

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

dapagliflozin propanediol (as dapagliflozin 5, 10mg)

6.15, 12.3mg

(포시가정 5, 10 밀리그램, 한국아스트라제네카(주))

제형, 성분.함량 :

- 1 정 중 dapagliflozin propanediol (as dapagliflozin 5, 10mg) 6.15, 12.3mg

효능 효과 :

- 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여

약제급여평가위원회 심의일

2014년 제5차 약제급여평가위원회 : 2014년 5월 8일

- 급여기준 자문위원회 심의일 : 2014년 3월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여”에 허가받은 경구제로 비교약제인 Sitagliptin, Linagliptin 대비 HbA1c 강하효과 등 효과면에서 비열등하였으며, 경제성 평가결과 비용 효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 meglitinide, α -glucosidase inhibitor, thiazolidinedione, DPP4 inhibitor 계열 약제 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 매우 강력하고, 선택적이며 가역적인 나트륨-글루코스-공동수송체2(SGLT2)의 저해제이며, glucose의 재흡수 억제 및 뇨 중 glucose의 배설에 관여하고, β -세포 기능이나 인슐린 민감도에 비의존적인 새로운 기전의 혈당강하제로서, 가이드라인 등에서 제 2형 당뇨병 환자의 치료제로 추천되고 있음.

▪ 신청품을 포함한 SGLT inhibitor는 HbA1c(%)를 0.5-1.0% 정도 감소시키며, 저혈당 유발의 위험성이 중등도이고, 체중을 감소시키는 경향성을 보임. 또한 신청품 투여로 인한 매우 흔한 이상 반응은 생식기 감염 및 요로 감염이었으며, 임상시험에서 이상반응으로 인해 투여 중단을 유발한 경우는 드물었음.

▪ SGLT2 inhibitor는 insulin 분비와 무관하게 선택적으로 작용하며, 뇨를 통해 배출가능한 glucose threshold 이상의 양을 배출시키지 않으므로 저혈당의 위험성이 낮은 임상적 특징을 가짐.

- 메타 분석 결과 신청품 투여군은 DPP4 inhibitors, thiazolidinediones, sulfonylureas계열 대비 유사한 수준의 HbA1c의 감소를 보였음. 또한, 저혈당 발생의 위험성(odds ratio)은 sulfonylureas계열 대비 낮고 DPP4 inhibitors, thiazolidinediones계열 대비 유사했으며, 체중 감소의 경향성은 DPP4 inhibitors 및 sulfonylureas계열 대비 높았음.

[Metformin 병용투여 glipizide 대조 임상시험]

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=814)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, glipizide 대조 3상 임상을 52주간 수행한 결과, 기저 상태 대비 HbA1C 감소 효과가 dapagliflozin 투여군이 glipizide 투여군 대비 비열등했음(mean difference: 0.00(95% CI -0.11, 0.11), upper limit of the 95% CI was <0.35%(non-inferiority margin)).

- 52주 시점에 기저상태로부터 체중이 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음에 비해, glipizide 투여군에서는 유의하게 증가했으며(-3.2kg vs. +1.2kg; p<0.0001), 한번 이상의 저혈당을 경험하는 비율이 dapagliflozin 투여군에서 glipizide 투여군 대비 유의하게 낮았음(3.5% vs. 40.8%; p<0.0001).
- Genital infection 및 lower urinary tract infection이 dapagliflozin 투여군에서 glipizide 투여군 대비 빈번하게 발생했으나, 투여 중단을 일으킨 경우는 드물었음.

[Metformin 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=546)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상을 24주간 수행한 결과, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음(-0.67% (-0.81 to -0.53; p=0.0002)[2.5mg], -0.70%(-0.85 to -0.56; p<0.0001)[5mg], -0.84%(-0.98 to -0.70; p<0.0001)[10mg] vs. -0.30%(-0.44 to -0.16)).

- 24주 시점에 기저 상태로부터 fasting plasma glucose 및 body weight가 위약군 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했으며(FPG: -0.99mmol/L(-1.28 to -0.69; p=0.0019)[2.5mg], -1.19mmol/L(-1.49 to -0.90; p<0.0001)[5mg], -1.30mmol/L(-1.60 to -1.00; p<0.0001)[10mg] vs. -0.33mmol/L(-0.62 to -0.04)), (TBW: -2.2kg(-2.7 to -1.8; p<0.0001)[2.5mg], -3.0kg(-3.5 to -2.6; p<0.0001)[5mg], -2.9kg(-3.3 to -2.4; p<0.0001)[10mg] vs. -0.9kg(-1.4 to -0.4)), therapeutic glycaemic response(HbA1c≤7%)에 도달된 환자의 비율이 위약군 대비 신청품(5, 10mg) 투여군에서 유의하게 높았으며(33.0%(25.4 to 40.6; p=0.1775) [2.5mg], 37.5%(30.0 to 45.2; p=0.0275)[5mg], 40.6%(32.9 to 48.3; p=0.0062) [10mg] vs. 25.9%(19.1 to 32.6)), 1주 시점의 fasting plasma glucose이 위약군 대비 신청품(5, 10mg) 투여군에서 유의하게 감소했음(-0.33mmol/L(-0.55 to -0.12) [2.5mg], -0.67(-0.88 to -0.45; p<0.0001)[5mg], -0.92(-1.14 to 0.69; p<0.0001)[10mg] vs. 0.07mmol/L(-0.14 to 0.28)).

- Metformin($\geq 1,500$ mg/day) 단독 요법으로 불충분한 혈당조절(기저 HbA1c 7-10%)을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=546)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상에 대한 102주 연장 시험 결과, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음(-0.48%(-0.68 to -0.29; p=0.0008)[2.5mg], -0.58(-0.77 to -0.39; p<0.0001)[5mg], -0.78%(-0.97 to -0.60); p<0.0001[10mg] vs. 0.02%(-0.20 to 0.23))

- 102주 시점에 위약군 대비 신청품 투여군에서 fasting plasma glucose는 위약군 대비 신청품 투여군(5,10mg)에서 유의하게 감소했으며(-1.07mmol/L(-1.42 to -0.72; p=0.0518)[2.5mg], -1.47mmol/L(-1.78 to -1.16; p=0.0003)[5mg],

-1.36mmol/L(-1.65 to -1.07; $p=0.0012$)[10mg] vs. -0.58mmol/L(-0.97 to -0.19)), total body weight가 위약군 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음 (-1.10kg(-1.91 to -0.29; $p<0.0001$)[2.5mg], -1.70kg(-2.48 to -0.91; $p<0.0001$)[5mg], -1.74kg(-2.51 to -0.96; $p<0.0001$)[10mg] vs. 1.36kg(0.53 to 2.20)). 또한, 102주 시점에 therapeutic glycaemic response($HbA1c \leq 7\%$)에 도달된 환자의 비율이 위약군 대비 신청품(5, 10mg) 투여군에서 유의하게 높았음($HbA1c$ (20.7%(14.0 to 27.3[2.5mg], 26.4%(19.4 to 33.4; $p=0.0176$)[5mg], 40.6%(23.7 to 39.3; $p=0.0011$)[10mg] vs. 15.4%(9.5 to 21.3)).

▪ 위약군 대비 dapagliflozin 투여군에서 생식기 감염의 발생률이 높았음(11.7%[2.5mg], 14.6%[5mg], 12.6%[10mg] vs. 5.1%).

- 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=1236$)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 3군(dapagliflozin과 metformin 병용 요법 vs. dapagliflozin 단독요법 vs. metformin 단독요법) 대조 임상시험을 24주간 수행한 결과, 기저상태로부터 $HbA1c(\%)$ 이 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했음(study 1: -0.86(95%CI -1.11 to -0.62; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], -0.70(95%CI -0.94 to -0.45; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: -0.53(95%CI -0.74 to -0.32; $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. DAPA10], -0.54(95%CI -0.75 to -0.33; $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. MET]).

▪ 기저 상태로부터 fasting plasma glucose(mmol/l)가 dapagliflozin 또는 metformin 단독 요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했고(study 1: -1.06(95%CI -1.48 to -0.63; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], -1.53(95%CI -1.96 to -1.10; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: -0.77(95%CI -1.16 to -0.39; $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. DAPA10], -1.42(95%CI -1.81 to -1.03; $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. MET]), $HbA1c \leq 7\%$ 에 도달한 환자의 비율(%)이 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 높았으며(study 1: 29.9(95%CI 20.8 to 39.0; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], 17.8(95%CI 8.1 to 27.4; $p=0.0003$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: 14.9(95%CI 5.9 to 23.9; $p=0.0012$)[DAPA10 + MET vs. DAPA10], 11.3(95%CI 2.1 to 20.6; $p<0.0165$)[DAPA10 + MET vs. MET]), 기저상태로부터 total body weight(kg)가 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했음(study 1: -0.05(95%CI -0.72 to 0.61, $p=0.8769$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], -1.37(95%CI -2.04 to -0.71, $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: -1.97(95%CI -2.64 to -1.30, $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. MET]).

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=180$)를 대상으로 24주간 다기관, 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 결과, 기저상태로부터 total body weight이 위약 대비 dapagliflozin(10mg/day) 투여군에서 유의하게 감소했으며(placebo corrected changes: -2.08kg(95% CI -2.84 to -1.31; $p<0.0001$), 이 양상은 102주 연장 임상시험 결과에서도 유지되었음(placebo corrected changes: -2.42kg(95% CI -3.64 to -1.21).

- 기저상태로부터 waist circumference이 위약대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했고 (placebo corrected changes: $-1.52\text{cm}(95\%\text{CI } -2.74, -0.31; p=0.0143)$), 기저상태로부터 fat mass가 위약대비 dapagliflozin(10mg/day)투여군에서 유의하게 감소했으며 (placebo corrected changes: $-1.48\text{kg}(95\%\text{CI } -2.22, -0.74; p=0.0001)$) 이 양상은 102 주 연장 임상시험 결과에서도 유지되었음.

[Sulfonylurea계 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Glimepiride 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=597$)를 대상으로 24주간 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 시험 결과, 기저상태로부터 HbA1c가 위약 대비 dapagliflozin($2.5, 5, 10\text{mg/day}$) 투여군에서 유의하게 감소했음 (Difference vs. PLA: $-0.44\%(-0.61 \text{ to } -0.27); p<0.0001[2.5\text{mg}]$, $-0.49\%(-0.67 \text{ to } -0.32); p<0.0001[5\text{mg}]$, $-0.68\%(-0.86 \text{ to } -0.51); p<0.0001[10\text{mg}]$)
 - 기저상태로부터 총 체중이 신청품 $5, 10\text{mg}$ 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했으며 (Difference vs. PLA: $-0.46\text{kg}(-1.08 \text{ to } 0.15; p=0.1410[2.5\text{mg}]$, $-0.84\text{kg}(-1.47 \text{ to } -0.21; p=0.0091[5\text{mg}]$, $-1.54\text{kg}(-2.17 \text{ to } -0.92; p<0.0001[10\text{mg}])$, HbA1c $<7\%$ 로 정의한 치료적 혈당 반응에 도달한 환자의 비율은 신청품 $5, 10\text{mg}$ 투여군에서 위약군 대비 유의하게 높았음 (13.0% vs. 30.3% ; $p=0.0001[5\text{mg}]$, 31.7% ; $p<0.0001[10\text{mg}]$). 또한 기저시점으로부터 75g-경구당부하검사(OGTT)로 평가한 식후 2시간 혈당(PPG)이 신청품 $5, 10\text{mg}$ 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했으며 ($-1.78\text{mmol/l}; p=0.0002[5\text{mg}]$, $-1.94\text{mmol/l}; p<0.0001[10\text{mg}]$ vs. -0.33mmol/l), 기저시점으로부터 FPG(free plasma glucose)이 신청품 $5, 10\text{mg}$ 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했음 ($-1.18\text{mmol/l}; p<0.0001[5\text{mg}]$, $-1.58\text{mmol/l}; p<0.0001[10\text{mg}]$ vs. -0.11mmol/l).
 - 심각한 이상 반응, 저혈당 사건, 생식기 감염은 위약군 대비 신청품 투여군에서 다소 빈번하게 발생했음.

[Thiazolidinedione계 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Pioglitazone 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=420$)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 시험 결과, 기저상태로부터 HbA1c(%)이 24주 및 48주 시점에 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음 (at weeks 24: $-0.82\pm 0.08; p<0.0001[5\text{mg}]$, $-0.97\pm 0.08; p<0.0001[10\text{mg}]$ vs. $-0.42\pm 0.08[\text{placebo}]$), (at weeks 48: $-0.95\pm 0.08[5\text{mg}]$, $-1.21\pm 0.07[10\text{mg}]$ vs. $-0.54\pm 0.08[\text{placebo}]$).
 - 24주 시점에 기저시점으로부터 FPG(mg/dl)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했으며 ($-24.9\pm 2.9; p<0.0001[5\text{mg}]$, $-29.6\pm 2.9; p<0.0001[10\text{mg}]$ vs. $-5.5\pm 2.9[\text{placebo}]$), 기저시점으로부터 75g 경부당부하 2시간 후 PPG(mg/dl)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음 ($-1.38\pm 0.16; p<0.0001[5\text{mg}]$, $-1.64\pm 0.16; p<0.0001[10\text{mg}]$ vs. $-0.31\pm 0.16[\text{placebo}]$). 또한 기저시점으로부터 total body weight(kg)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음

(0.09 ± 0.28 ; $p < 0.0001$ [5mg], -0.14 ± 0.28 ; $p < 0.0001$ [10mg] vs. 1.64 ± 0.28 [placebo]).

- 생식기 감염은 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 자주 발생했으며 (8.6-9.2% vs. 2.9%), 부종은 dapagliflozin 투여군 대비 위약 투여군에서 자주 발생했음 (2.1-4.3% vs. 6.5%).

[DPP4 저해제 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Sitagliptin (100mg/day) 요법 (단독요법 또는 metformin ($\geq 1,500$ mg/day) 병용투여)으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자 (n=432)를 대상으로 24주간 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 시험 결과, 기저상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 dapagliflozin, sitagliptin 병용 투여군, dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음 (placebo corrected change: -0.6% (95% CI -0.8 to -0.3 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -0.4% (95% CI -0.6 to -0.2 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin plus metformin]).

- 기저시점으로부터 total body weight이 위약 대비 dapagliflozin, sitagliptin 병용 투여군 및 dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했으며 (placebo corrected change: -1.9 kg (95% CI -2.5 to -1.2 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -1.9 kg (95% CI -2.6 to -1.1 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin plus metformin]), 기저시점에 HbA1c $\geq 8\%$ 인 환자군의 24주 시점의 기저시점으로부터 HbA1C이 위약 대비 dapagliflozine과 sitagliptin 병용 투여군 및 dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음 (placebo corrected change: -0.9% (95% CI -1.2 to -0.6 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -0.8% (95% CI -1.1 to -0.5 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin plus metformin]). 또한, 기저시점으로부터 FPG이 위약 대비 dapagliflozin과 sitagliptin 병용 투여군 및 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음 (placebo corrected change: -26.6 mg/dl (95% CI -36.3 to -16.9 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -29.2 mg/dl (95% CI -38.0 to -20.4 ; $p < 0.0001$ [sitagliptin plus metformin]).

[Insulin 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Insulin 단독요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자 (n=800)를 대상으로 48주간 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상 시험 결과, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음 (Difference vs. PLA + INS: -0.32% (95% CI -0.48 to -0.16 ; $p < 0.001$ [DAPA2.5mg], -0.49% (95% CI -0.65 to -0.33 ; $p < 0.001$ [DAPA5mg], -0.54% (95% CI -0.70 to -0.38 ; $p < 0.001$ [DAPA10mg]).

- 48주 시점에 기저시점으로부터 총 체중 (Total body weight, kg)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음 (Difference vs. PLA + INS: -1.78 kg (95% CI -2.53 to -1.03 ; $p < 0.001$ [DAPA2.5mg], -1.82 kg (95% CI -2.56 to -1.07 ; $p < 0.001$ [DAPA5mg], -2.43 kg (95% CI -3.18 to -1.68 ; $p < 0.001$ [DAPA10mg]).

- 24주 시점에 기저시점으로부터 평균 일일 인슐린 용량이 위약군에서 증가했음에 비해, dapagliflozin 투여군에서 감소했으며(Difference vs. PLA + INS: -7.60U(95% CI, -10.32 to -4.87U)[2.5mg], -6.28U(95% CI, -8.99 to -3.58%)[5mg], -6.82U(95% CI, -9.56 to -4.09U)[10mg]), 평균 일일 투여 인슐린 용량이 10% 이상 감소한 환자의 비율이 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 6.3%-8.9% 감소했음(Difference vs. PLA + INS: 6.3%(95% CI, -0.4 to 13.0 ;p=0.064[2.5mg], 6.3%(95% CI, -0.3 to 12.9 ;p=0.060[5mg], 8.9%(95% CI, 1.9 to 15.9 ;p=0.013[10mg])).
- Insulin 단독요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=800)를 대상으로 48주간 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상 시험에 대한 104주 연장 임상시험 결과, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -0.4%(95% CI -0.6 to -0.2); p=0.0002[DAPA5/10mg], -0.4%(95% CI -0.6 to -0.2); p=0.0007[DAPA10mg])).
- 104주 시점에 기저시점으로부터 총 체중(Total body weight, kg)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했으며(Difference vs. PLA + INS: -2.86kg(95% CI -3.92 to -1.80); p<0.0001[DAPA5/10mg], -3.33kg(95% CI -4.38 to -2.27); p<0.0001[DAPA10mg]), 기저시점으로부터 평균 일일 인슐린 용량이 위약군에서 증가했음에 비해, dapagliflozin 투여군에서 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -16.8U(95% CI, -20.5 to -8.0; p<0.0001)[DAPA5/10mg], -19.2U(95% CI, -25.5 to -12.9; p<0.0001)[DAPA5mg]). 또한, 인슐린 용량이 up-titration되었거나 불충분한 혈당 조절로 시험을 중단한 비율이 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 낮았음(Difference vs. PLA + INS: -23.9%(95% CI, -33.0 to 14.8)[DAPA5/10mg], -24.9%(95% CI, -34.1 to -15.6)[DAPA10mg])).
- Dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 생식기 감염(7.4-14.3% vs. 3.0%), 요로 감염(8.4-13.8% vs 5.6%)의 발생률이 높았음.
- 학회 의견에 따르면, 신청품은 SGLT-2(sodium/glucose cotransporter 2) 억제제로서 정상적인 내인성 포도당의 생성을 손상시키지 않으면서 신장에서의 포도당 재흡수를 감소 시킴으로써 공복 및 식후 혈당을 개선시키는 새로운 계열의 당뇨병 용제임. 또한 저혈당의 발현이 낮고 체중을 감소시키는 효과가 있기 때문에 기존 약제에 비해 우수한 복용 순응도와 이를 통한 지속적인 혈당 조절효과를 기대할 수 있는 제제임.

○ 비용 효과성

- 허가사항, 당뇨병 용제 급여기준, 가이드라인, 급여기준 자문위원회 의견 등을 고려하여 acarbose, voglibose, miglitol, repaglinide, nateglinide, mitiglinide, pioglitazone, rosiglitazone, lobeglitazone, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin을 신청품의 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 1일 투약비용은 원으로서 대체 약제의 가중 일일 투약비용인 원 대비 고가임.

- 신청품은 비교 약제인 sitagliptin, linagliptin 대비 비용 최소화 분석 결과, 간접비교 결과에서 HbA1c(%)강하 등의 효과 면에서 비교 약제 대비 비열등성 인정 가능하며, 총 소요 비용은 sitagliptin 대비 원 절감되었으며 linagliptin 대비 하여 비용 효과성 수용 가능함.

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수는 이고, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원이 되고, acarbose, voglibose, miglitol, repaglinide, nateglinide, mitiglinide, pioglitazone, rosiglitazone, lobeglitazone, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin의 대체로 재정소요 금액은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원 증가될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국에 등재되어 있음.

Reference

바른심사 바른평가, 신뢰받는 심사평가원

